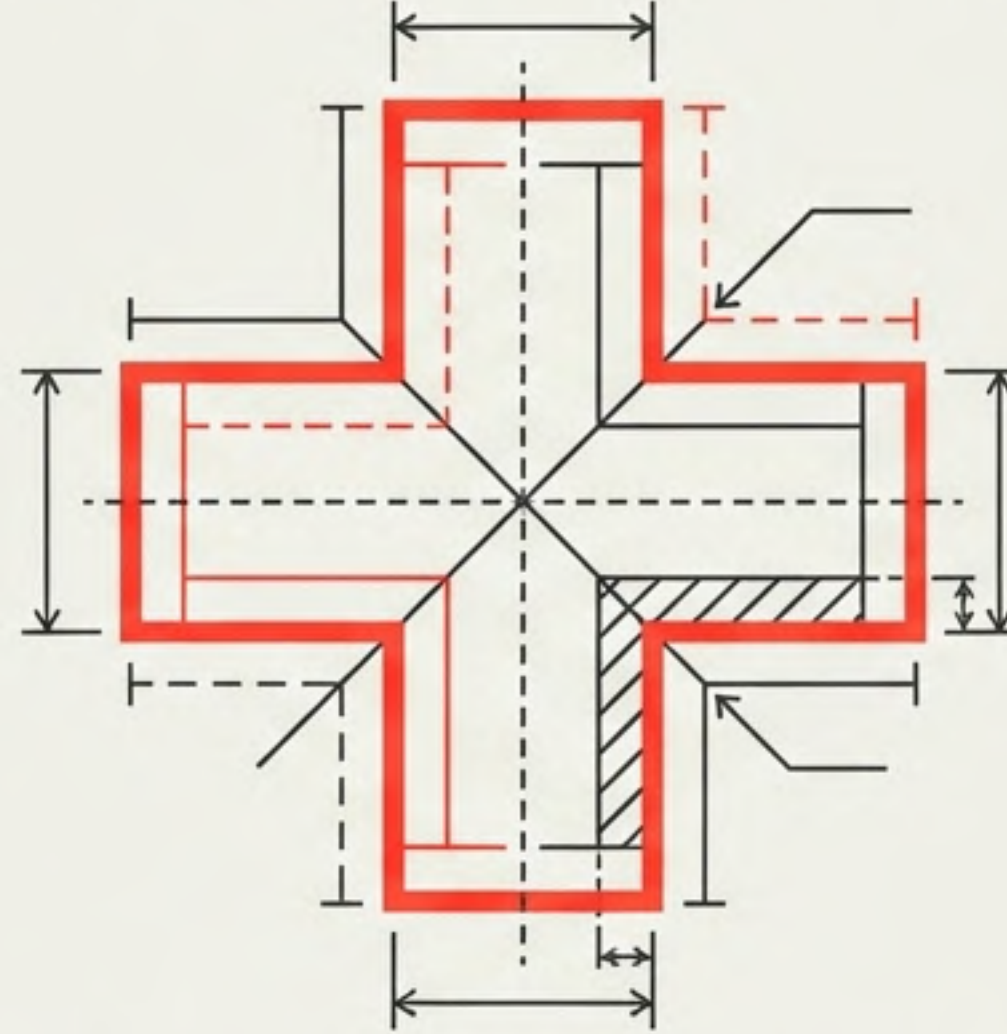


Yaralanmalarda İlk Yardım: Hayat Kurtaran Müdahaleler

Tanı, Değerlendir ve Harekete Geç



Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulması durumunda yapılacaklar kılavuzu.

Yara Nedir ve Çeşitleri



KESİK YARALAR

Bıçak, cam, kesici aletler.
Basit yaralardır, derinlik
kolay belirlenir.



EZİKLİ YARALAR

Taş, yumruk, sopa çarpması.
Yara kenarları eziktir,
doku zedelenmesi vardır.



DELİCİ YARALAR

Uzun ve sivri aletler.
Derinlik hakimdir, tetanos
tehlikesi yüksektir.



PARÇALI YARALAR

Çekme etkisi ile oluşur.
Doku, organ ve saçlı deri
zarar görebilir.

Enfeksiyon ve Yüksek Risk Faktörleri

- ⚠ Dikişleri ayrılmış veya kenarları muntazam olmayan yaralar.
- ⚠ Çok kirli ve derin yaralar.
- ⚠ Ateşli silah yaraları.
- ⚠ Isırma ve sokma ile oluşan yaralar.

**6 Saat Kuralı:
Gecikmiş Yaralar**



BELİRTİLER

Ağrı, Kanama, Yara kenarının ayrılması.

Değerlendirme Protokolü



Adım 1: Yaşam Bulguları

ABC Değerlendirmesi (Önce hayati fonksiyonlar).



Adım 2: Yara Değerlendirmesi

Oluş şekli, Süresi, Kanama durumu.

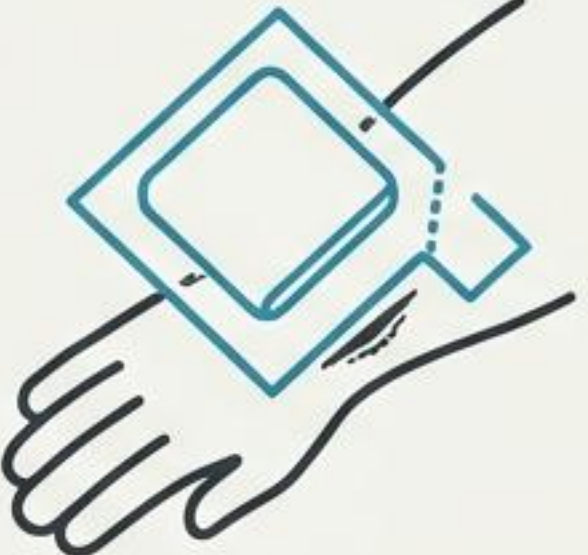


Adım 3: Yabancı Cisim Kontrolü

Var mı? Yok mu?

Yaradaki yabancı cisimlere dokunulmamalıdır!

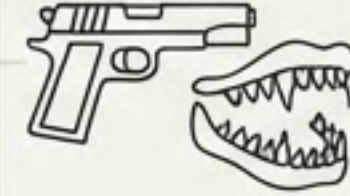
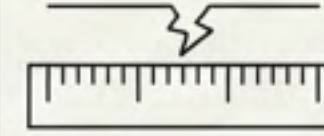
Genel İlk Yardım Adımları

1. KANAMA	2. KORUMA	3. SAĞLIK	4. AŞI
			
Kanama durdurulur.	Yara üzeri kapatılır.	Sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır.	Tetanos konusunda uyarıda bulunulur.

Acil durumlarda profesyonel yardım çağırın: 112

Ciddi Yaralanma Kriterleri

Ne Zaman 112 Aranmalı?



Ciddi Yaralanmalarda Müdahale

YAPMA / DO NOT



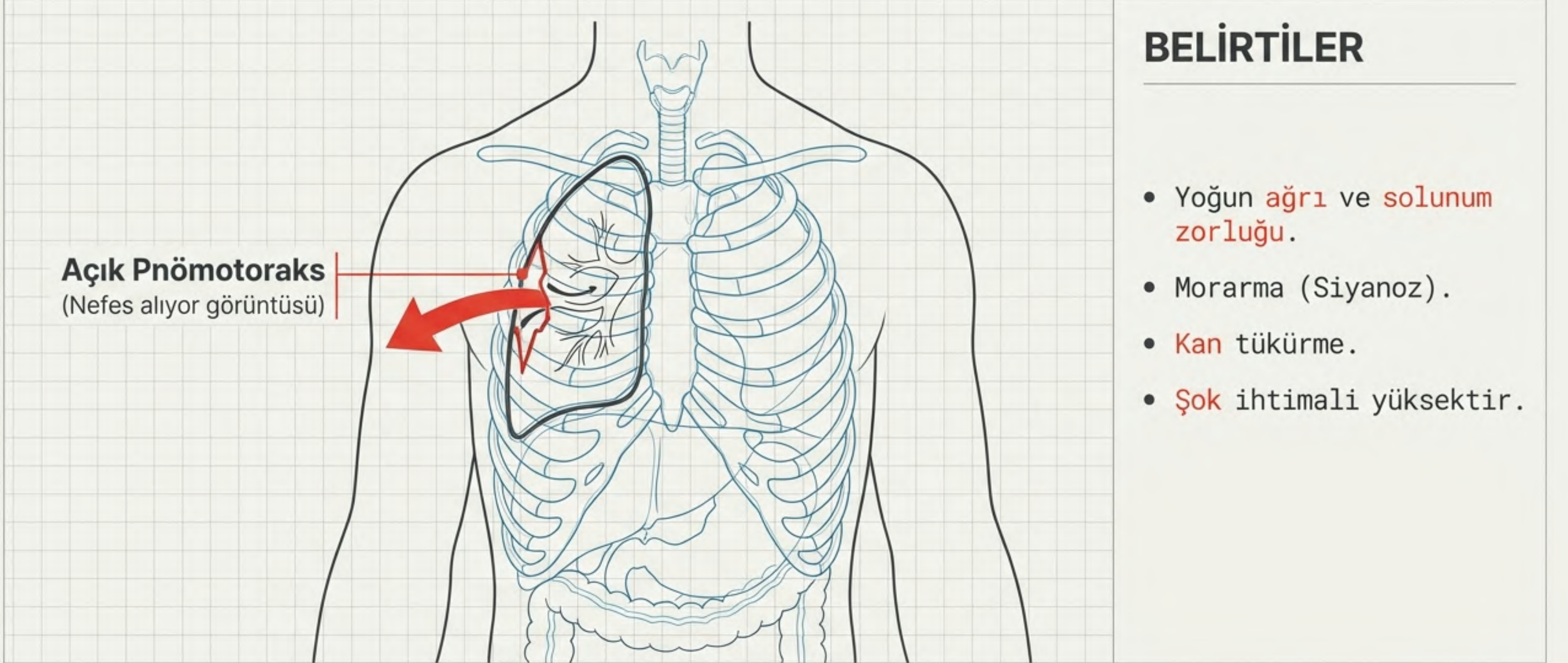
- Yaraya saplanan yabancı cisimler çıkarılmaz.
- Yara içi kurcalanmaz.

YAP / DO

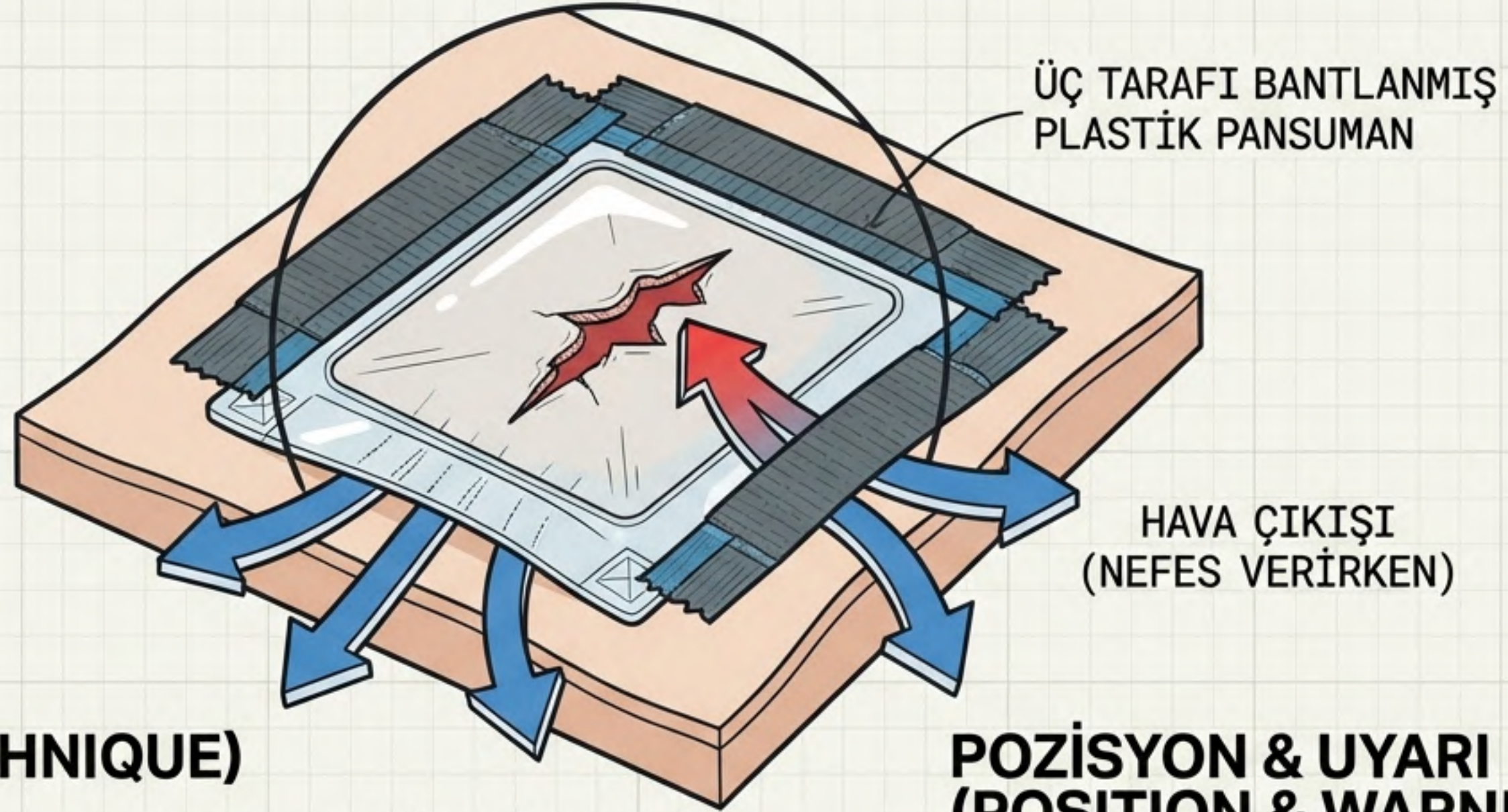


- Kanama varsa durdurulur (cismin etrafından).
- Yara temiz, nemli bir bezle örtülür.
- Yara üzerine bandaj uygulanır.
- **Tıbbi yardım istenir (112).**

Kritik Durum: Delici Göğüs Yaralanmaları



Göğüs Yaralanmalarında Müdahale



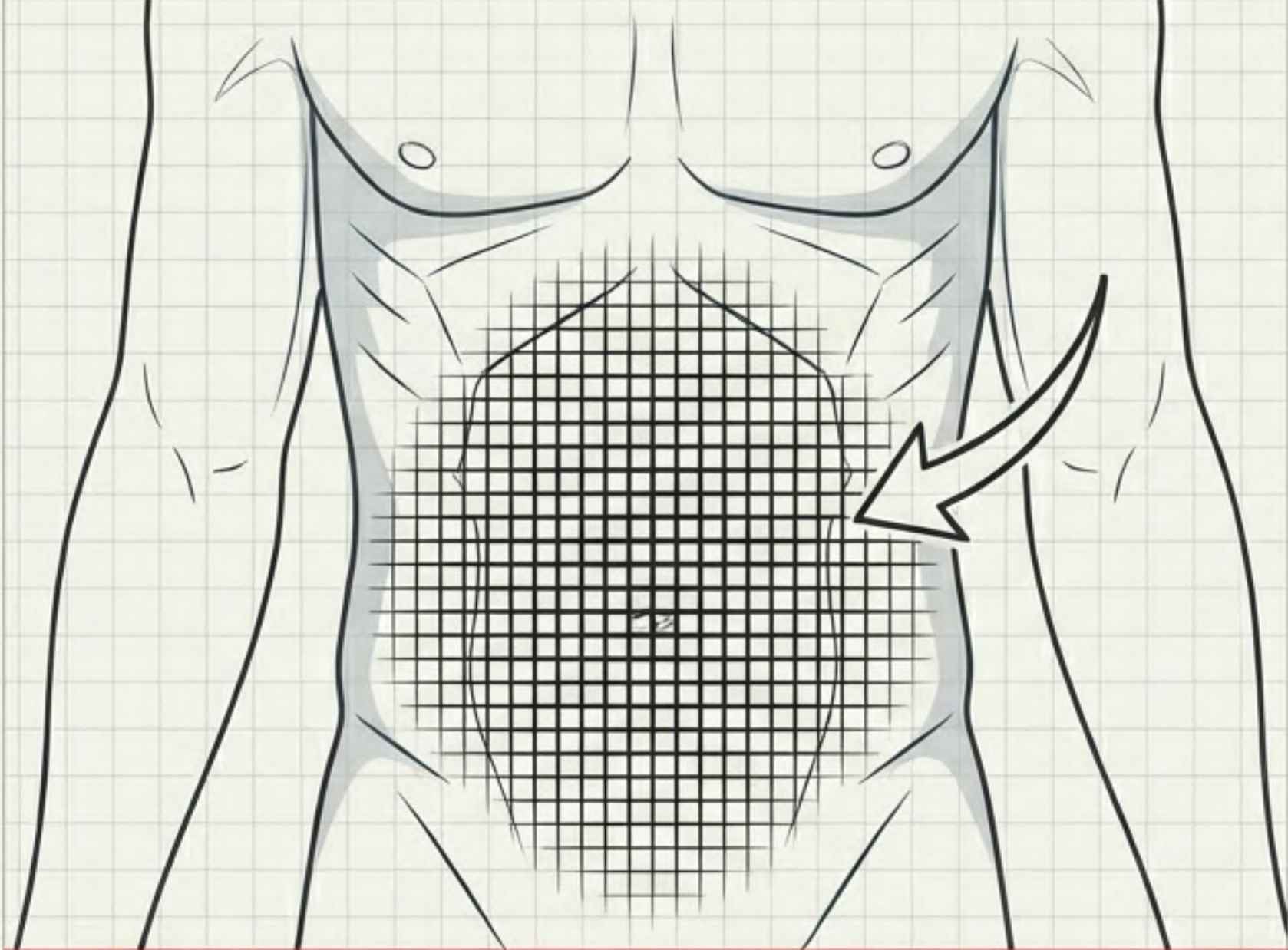
TEKNİK (THE TECHNIQUE)

- **Malzeme:** Plastik poşet, naylon vb. sarılmış bez.
- **Uygulama:** Sadece **3 ucu bantlanır**, **bir ucu açık** bırakılır.
- **Neden:** Nefes alırken yapışır (**hava girmez**), nefes verirken açılır (**hava çıkar**).

POZİSYON & UYARI (POSITION & WARNING)

- **Pozisyon:** Bilinci açık ise **Yarı Oturur**.
- **Uyarı:** Ağızdan **hiçbir şey verilmez**.

Kritik Durum: Delici Karın Yaralanmaları



Belirti:
Karın tahta
gibi sert.

- İç/dış kanama ve buna bağlı şok.
- Bağırsakların dışarı çıkması.

DİKKAT: Dışarı çıkan organlar asla içeri sokulmaya çalışılmaz!

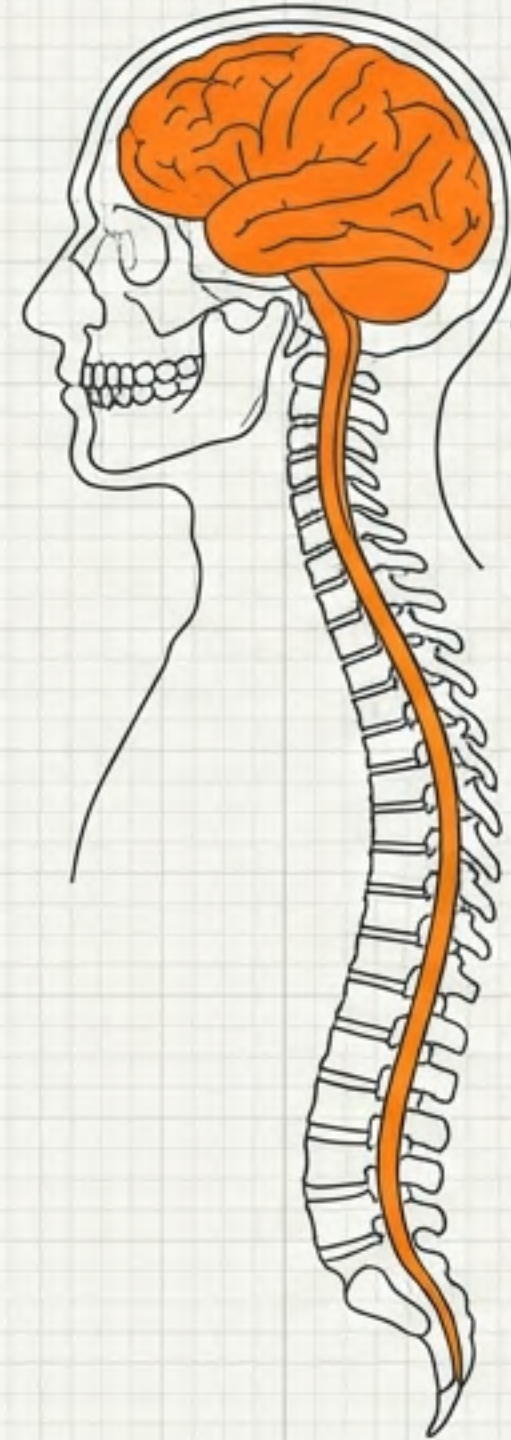
Karın Yaralanmalarında Pozisyon ve Müdahale



Kafatası ve Omurga Yaralanmaları



Trafik kazalarındaki ölümlerin %80'i bu yaralanmalardan kaynaklanır.



Hasar sadece kemikte değildir; Merkezi Sinir Sistemi etkilenebilir.

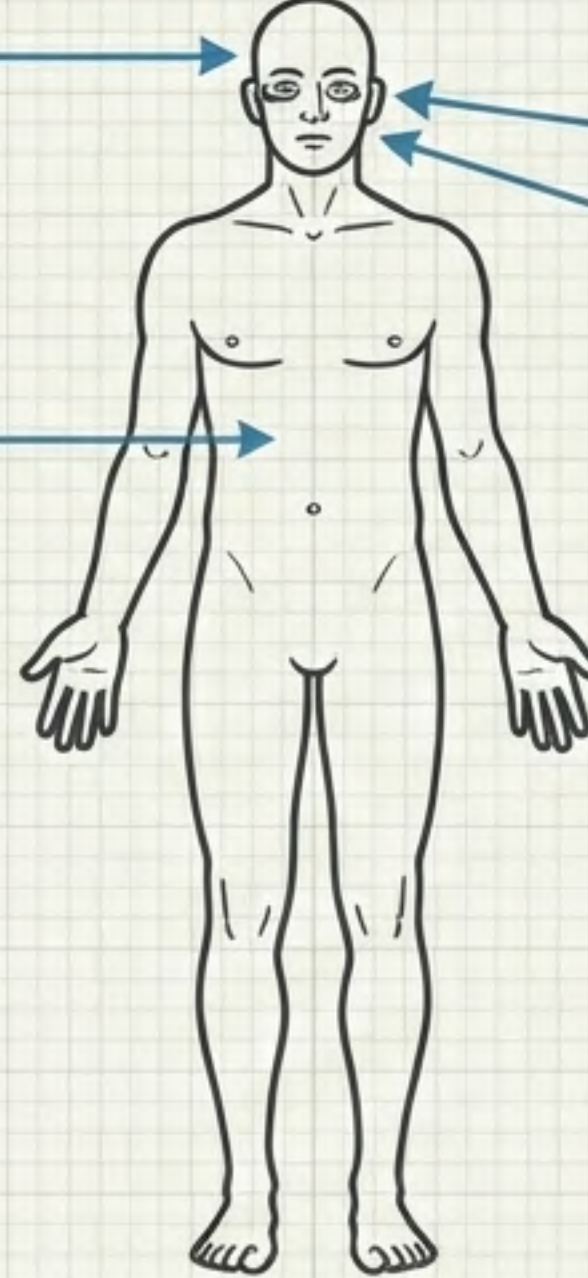
Nedenler:

- Yüksekten düşme
- Trafik kazaları
- Yıkıntı altında kalma
- Spor/İş kazaları.

Sinir Sistemi Hasarı Belirtileri

Bilinç deęişiklięi,
hafıza kaybı.

Sırtta ağrı veya
şekil bozukluğu.



Göz çevresinde morluk
(Rakun gözü).
Kulak/Burundan sıvı
veya kan gelmesi.

Parmaklarda karıncalanma,
his kaybı.

Varsayım: Bilinci kapalı tüm travma hastaları omurga yaralanması olarak kabul edilmelidir.

Omurga Yaralanmalarında Müdahale: Sabitleme



- Bilinci açıksa hareket etmemesi sağlanır.
- Asla yalnız bırakılmaz.
- Sarsıntıya maruz bırakılmaz.

Sadece hayati tehlike varsa (yangın vb.) düz pozisyonda sürüklenir. Aksi takdirde **112 beklenir.**

Hayat Kurtaran Özet Tablosu

GENEL



Temizle, Kapat, Tetanos Aşısı.

GÖĞÜS



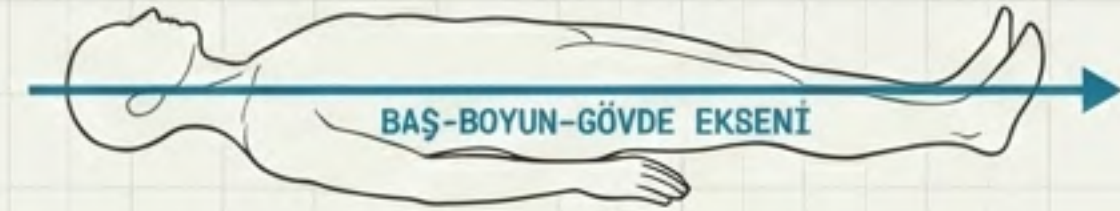
3 tarafı kapalı bandaj +
Yarı oturur pozisyon.

KARIN



Organları itme, nemli bezle ört
+ Sırt üstü, dizler bükük.

OMURGA



Baş-Boyun-Gövde eksenini koru
+ Sabitle.

SOĞUKKANLI OL, 112'Yİ ARA.